혈액순환제, 제대로 알고 드세요

"다리가 무겁다·저리다·차다, 어지럽다" — 원인에 따라 약이 다릅니다. 무엇이 정말 효과가 있고 무엇이 그렇지 않은지, 안전하게 쓰는 법까지 함께 봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

‘혈액순환제’는 한 가지 약이 아닙니다

흔히 한데 묶지만, 작용도 적응증도 다른 네 갈래의 약입니다

4가지

은행엽 · 정맥순환제 · 말초동맥질환약 · 뇌순환개선제 — 서로 다른 약을 한 이름으로 부르고 있을 뿐입니다.

왜 중요한가요

원인(정맥·동맥·뇌·신경)에 맞춰 약을 골라야 효과가 있습니다. 맞지 않으면 효과는 없이 출혈·부작용 위험만 남고, 보험에서도 인정받기 어렵습니다. 그래서 “순환이 안 돼서”라는 막연한 처방 대신 원인을 먼저 나눕니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESVS 2022 만성정맥질환 지침 · ACC/AHA 2024 말초동맥질환 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

같은 '혈액순환'이 아닙니다 — 3가지 길

동맥·정맥·미세순환은 생기는 문제도, 필요한 약도 다릅니다

심장 → 발끝으로 보내는 길

산소·영양을 실어 나릅니다. 좁아지면 걸을 때 종아리 통증(파행)·발 냉증이 생깁니다.

발끝 → 심장으로 돌리는 길

피를 위로 올려보냅니다. 판막이 고장나면 붓고 무겁고 저녁에 심해집니다.

가는 혈관과 신경의 문제

저림·시림으로 나타나며, '혈액순환제'가 1차 치료가 아닐 때가 많습니다.

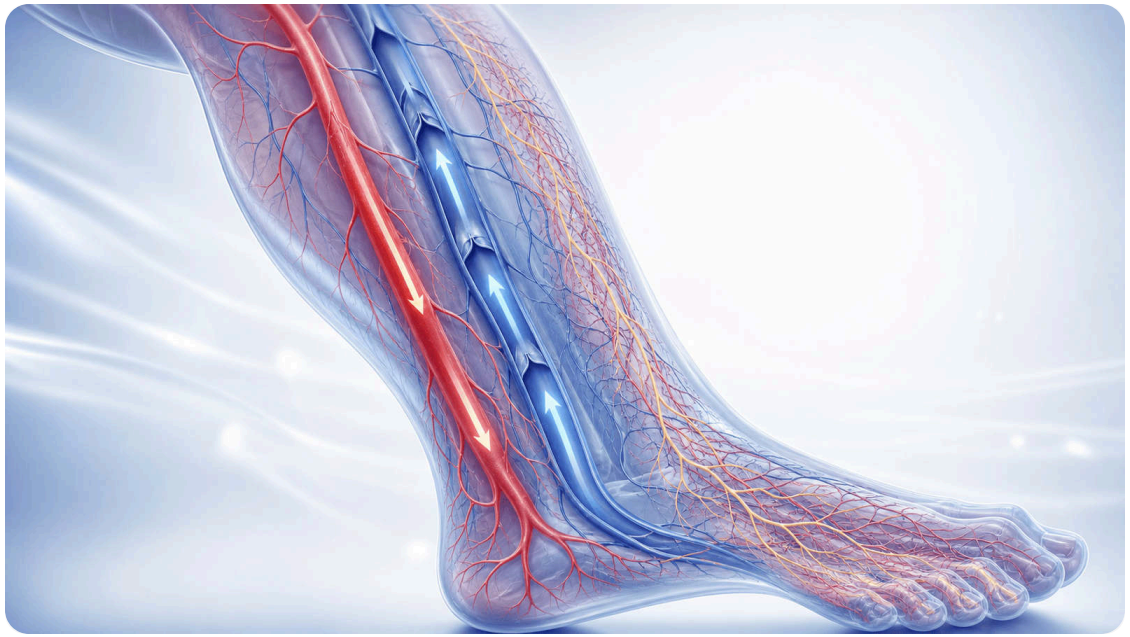


그림 · 같은 '혈액순환'이 아닙니다 — 3가지 길(설명용 그림)

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESVS 2022 만성정맥질환 지침 · ACC/AHA 2024 말초동맥질환 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

“무겁다·저리다·차다” — 먼저 원인을 나눕니다

같은 다리 증상도 원인에 따라 치료가 완전히 다릅니다

무겁다 · 붓는다

저녁에 붓고 무거우면 정맥질환일 수 있어 압박요법·정맥순환제를 고려합니다.

걸으면 아프다

걸으면 아프고 쉬면 호전 → 말초동맥질환. 발목혈압(ABI) 검사.

저리다 · 시리다

말초신경병증·디스크·갑상선·빈혈·레이노 등 비혈관 원인이 흔합니다.

어지럽다 · 귀가 울린다

전정·청력 평가가 먼저. 은행엽을 습관처럼 쓰지 않습니다.

원인 진단이 먼저 — 막연한 ‘혈액순환’ 처방은 근거가 약합니다.

근거 · ESVS 2022 만성정맥질환 지침 · ACC/AHA 2024 말초동맥질환 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

추위에 손끝 색이 변하면 레이노 현상을 살핍니다

색이 변하는 상황과 보온 뒤 회복, 함께 나타나는 증상을 알려 주세요

추위·찬물과 색 변화

손끝이 **노랗게·하얗게·파랗게** 변하고 따뜻해지면 돌아오는 양상이 단서입니다. 언제 변하는지, 보온 뒤 회복되는지 설명해 주세요.

다른 증상도 함께

관절통·관절 부종, 입마름·눈마름이 함께 있는지 확인합니다. 항핵항체(ANA) 양성과 레이노가 함께 있으면 류마티스 진료를 고려합니다.

항체 하나로 진단하지 않습니다

ANA 양성만으로 자가면역질환을 정하지 않습니다. 손끝 변화와 동반 증상을 함께 보고 필요한 검사와 진료를 정합니다.

저림·시림을 모두 같은 혈액순환 문제로 묶지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 자가항체 검사 해석의 핵심 포인트(홍석찬)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

걷기 통증은 척추와 신경에서도 생깁니다

추간판탈출증·척추관협착증도 엉치·다리 통증과 파행을 일으킵니다



통증 양상을 설명하세요

어디가 아픈지, 언제 시작했는지, 어떤 자세·활동에서 심해지거나 나아지는지 알려 주세요. 영상만으로 원인을 정하지 않습니다.



저림과 힘의 변화를 함께

전기가 오거나 화끈거리고 따끔거리는 느낌은 신경 문제의 단서입니다. **감각 저하·근력 변화**를 함께 평가합니다.



보행 거리가 짧아진다면

보행 거리가 점점 짧아지거나 감각이 떨어지고 힘이 빠지면 **척추 전문 진료**가 필요합니다. 수술도 증상·경과·치료 반응을 함께 봅니다.

혈관과 척추 원인을 구분해 검사·치료를 정합니다.

아산 28회 연수강좌 — 허리 통증의 진단과 치료(조재환)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

정맥 판막이 고장나면 — 붓고 무거워집니다

다리 정맥의 판막이 약해져 피가 거꾸로 고이는 병입니다

한 방향으로만 열리는 판막

정맥 속 판막이 한 방향으로만 열려 피를 심장 쪽으로 차곡차곡 올려보냅니다.

판막이 새면 피가 거꾸로

판막이 약해지면 피가 다리로 역류·정체 → 압력이 올라가 붓기·무거움·거미양 정맥이 생깁니다.

약은 증상을 줄일 뿐

정맥순환제는 부종·무거움을 덜어주지만, 늘어난 정맥·정맥류 자체를 없애지는 못합니다.

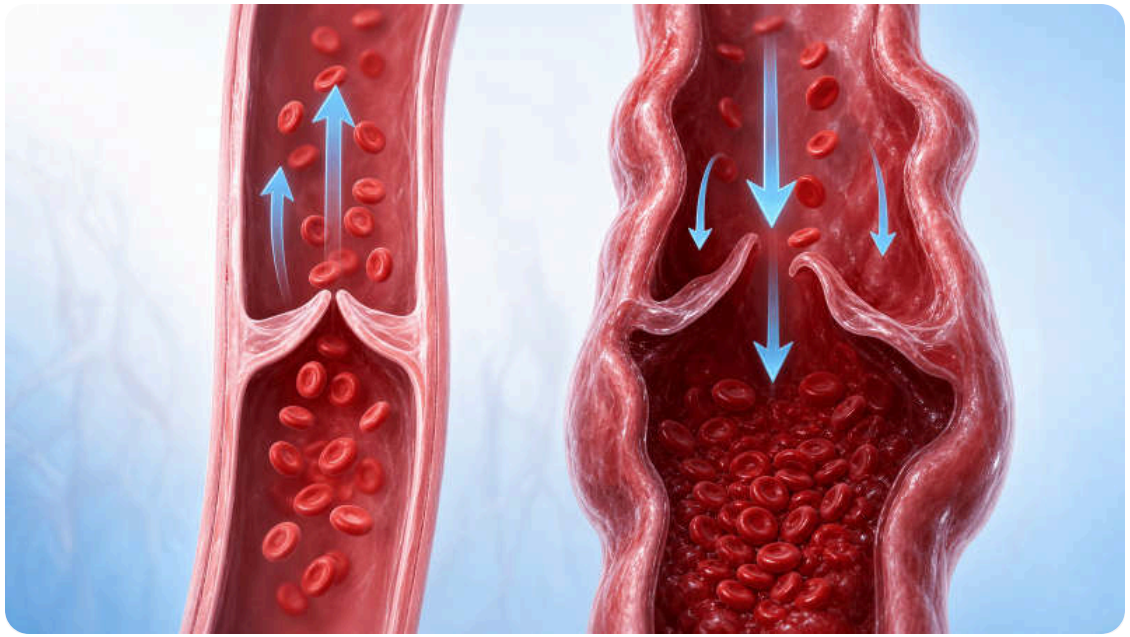


그림 · 정맥 판막이 고장나면 — 붓고 무거워집니다(설명용 그림)

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 만성정맥질환 · 정맥 판막부전·역류 기전 (ESVS 2022)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

정맥질환 — 압박이 1차, 약은 보조

압박스타킹·다리 올리기·체중관리가 먼저, 정맥순환제는 증상 보조



그림 · 정맥질환 — 압박이 1차, 약은 보조(설명용 그림)

압박요법이 가장 효과적

압박스타킹 착용, 다리 올리기, 자주 걷기, 체중관리 — 비약물 관리가 핵심입니다.

정맥순환제 (디오스민·미세정제 플라보노이드 분획 (MPFF) 등)

디오스민·미세정제 플라보노이드 분획(MPFF)·호스체스트넛 등이 부종·무거움을 '약간' 줄여주는 대증 보조약입니다.

이럴 땐 혈관 진료

한쪽만 심한 부종·피부 변화·궤양·튀어나온 정맥류 → 초음파와 혈관 시술 상담이 필요합니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 압박요법 1차 · 정맥활성약 부종 개선 중등도 확실성 (Cochrane 2020 · ESVS 2022)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

걸으면 종아리가 아프다 — 동맥이 좁아진 신호

말초동맥질환(PAD) — 동맥이 좁아져 근육에 피가 부족해집니다

걷다 아프고, 쉬면 풀린다

걸으면 종아리·허벅지가 아프고 멈추면 1~2분 내 호전(간헐성 파행). 심하면 쉴 때도 아프고 발에 상처가 낫지 않습니다.

콜레스테롤로 좁아진 동맥

흡연·당뇨·고지혈증·고혈압이 동맥경화를 키워 혈관을 좁힙니다.

발목혈압(ABI)으로 진단

팔과 발목의 혈압비를 재는 간단한 검사로 객관적으로 진단합니다.

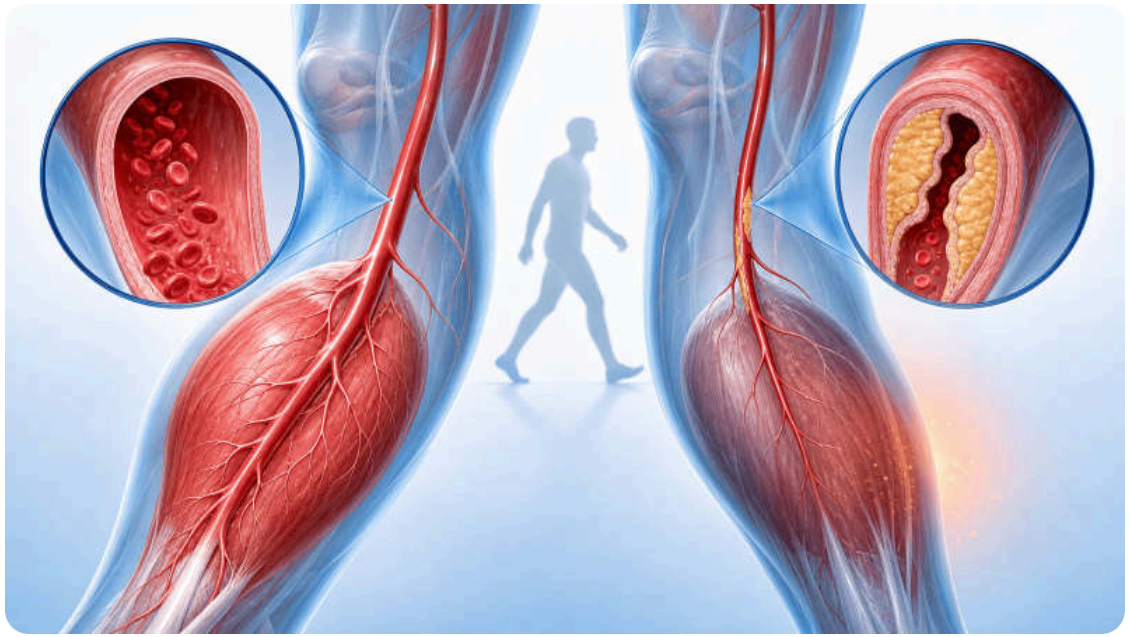


그림 · 걸으면 종아리가 아프다 — 동맥이 좁아진 신호(설명용 그림)

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 말초동맥질환 간헐성 파행 · ABI 진단 (ACC/AHA 2024)

발목혈압이 정상처럼 보여도 증상을 함께 봅니다

발목상완지수(ABI)는 막힘, 맥파전달속도(PWV)는 혈관의 뻣뻣함을 봅니다

혈관이 잘 눌리지 않을 때

당뇨병·고령·투석 중인 만성콩팥병·장기 스테로이드 복용에서는 발목혈압이 높게 나와 막힘이 가려질 수 있습니다. 당뇨병 환자의 **5~10%**에서 이런 현상이 나타날 수 있습니다.

ABI >1.4이면 추가 평가

혈관 석회화로 잘 눌리지 않는 상태를 생각하고 **발가락상완지수(TBI)·혈관 초음파**로 더 살핍니다.

PWV와 역할이 다릅니다

PWV는 동맥 경직도와 심혈관 위험을 보는 지표입니다. **혈관의 막힘을 진단하는 ABI와 다릅니다.** 수치가 높다는 이유만으로 같은 약을 쓰지 않습니다.

쉬어도 아프거나 상처가 있으면 ABI 결과와 관계없이 진료를 서두릅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

걷기 통증이 지속되면 운동 뒤 발목혈압도 봅니다

쉬고 잰 ABI가 정상처럼 보여도 운동 전후의 변화가 단서가 됩니다

운동 뒤 다시 측정

전형적인 걷기 통증이 계속되면 휴식 시 검사에 더해 **트레드밀 운동 뒤 ABI**를 측정해 진단율을 높일 수 있습니다.

운동 뒤 확인하는 변화

운동 뒤 발목혈압이 **20% 이상 감소**하거나 회복에 **3분 이상** 걸리는지를 살핍니다. 증상과 혈관 상태를 함께 보고 의료진이 해석합니다.

한 번의 정상 수치만으로 지속되는 증상을 넘기지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 말초동맥질환, 언제 의심하고 어떻게 치료할까?(김태오)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

말초동맥질환 — 운동과 위험인자 관리가 1차

약보다 먼저 걷기 운동과 금연·스타틴이 핵심입니다

통증 직전까지 걷고 쉬기

걷다 아프면 쉬기를 반복하는 '감독 운동'이 보행거리를 가장 많이 늘립니다.

금연·스타틴·혈압/혈당

금연이 가장 중요. 스타틴·혈압·혈당·항혈소판제로 동맥경화 진행을 늦춥니다.

실로스타졸 — 보행거리 ↑

파행 증상·보행거리를 개선하는 1차 증상약. 단, 심부전엔 금기입니다.

권장 안 함 · 펜톡시필린

펜톡시필린은 권하지 않음 간헐성 파행에는 효과 근거가 약해 권장하지 않습니다.

통증 없는 단순 냉감·저림에 검사 없이 장기 처방하는 것은 권하지 않습니다.

근거 · 감독 운동요법·실로스타졸 Class 1 / 펜톡시필린 비권장 (ACC/AHA 2024)

걷기 운동은 정해진 프로그램으로 이어갑니다

안정된 파행에서는 약물치료와 함께 감독하에 보행 운동을 합니다

관리·감독 아래 시작

심혈관 재활프로그램처럼 의료진이 관리하는 환경에서 **통증이 생길 때까지 걷고 쉬기**를 반복합니다. 운동 강도는 프로그램 안내를 따릅니다.

3-3-3 요법

한 번에 **30~45분 이상**, **주 3회 이상**, **최소 12주(3개월) 이상** 시행하는 프로그램입니다. 보행거리와 증상 변화를 함께 평가합니다.

실로스타졸의 역할

12~24주 치료에서 보행거리가 50~67% 증가한 연구 결과가 있습니다. 파행 완화용이며 심혈관 사건 예방약을 대신하지 않습니다. **심부전에는 금기**입니다.

차갑고 저리다는 이유만으로 검사 없이 약을 추가하지 않습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

다리 치료와 심장·뇌혈관 보호를 함께 합니다

말초동맥질환은 여러 부위 동맥경화가 함께 있을 수 있습니다

두 가지 치료 목표

다리 통증·상처·절단 위험을 줄이는 목표와 **심근경색·뇌졸중·심혈관 사망**을 예방하는 목표를 함께 봅니다. 다리 증상이 좋아져도 위험인자 관리는 이어갑니다.

약마다 목적이 다릅니다

아스피린·클로피도그렐은 사건 예방, 실로스타졸은 파행 완화가 목적입니다. 고위험 환자에서는 **아스피린+저용량 리바록사반**도 출혈 위험과 함께 검토합니다.

금연·혈압·혈당·콜레스테롤 관리와 처방약의 목적을 함께 확인합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

쉬어도 아프거나 상처가 낫지 않으면 서두르세요

갑작스러운 다리 변화는 걷기 운동이나 약 추가만으로 기다릴 상황이 아닙니다

갑작스러운 혈류 감소

2주 미만에 갑자기 생긴 혈류 감소로 다리 생존이 위협받는 급성 사지허혈은 **응급 평가**가 필요합니다. 차가움·색 변화·감각·힘의 변화를 알립니다.

휴식기 통증·낫지 않는 상처

쉬어도 아픈 발, 2주 넘는 궤양, 검게 변한 발끝은 만성 사지위협 허혈의 양상입니다. 상처·혈류·감염을 함께 보고 치료를 계획합니다.

검사 수치와 관계없이 의뢰

상처나 휴식기 통증이 있으면 ABI와 관계없이 전문 진료를 받습니다. 혈류 재개통과 상처 치료를 여러 진료과가 함께 계획합니다.

증상의 시작 시점과 변화를 진료 때 구체적으로 알려 주세요.

아산 28회 연수강좌 — 말초동맥질환, 언제 의심하고 어떻게 치료할까?(김태오)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

은행잎(은행엽) — 무엇에 듣고, 무엇에 안 듣나

매우 흔히 쓰지만, 효과가 입증된 곳은 제한적입니다

+ 근거가 있는 사용

- 경도~중등도 치매의 증상 보조 — 표준화 추출물에서 인지·일상생활 개선
- 일부 어지럼(중추성) 보조 — 단, 어지럼 원인 감별이 먼저
- 내약성은 대체로 좋은 편 (위장 불편 정도)
- 효과를 보려면 보통 수주~3개월 써 보고 재평가
- 표준화 은행잎 추출물(EGb 761)에서 근거가 쌓임 — 함량·제형이 중요

vs

– 근거가 약하거나 없는 사용

- 치매 '예방' — 대규모 연구에서 효과 입증 실패
- 이명(귀울림) — 표준치료로 권장하지 않음
- 간헐성 파행 — 임상적 이득 없음
- 막연한 '혈액순환' 목적의 장기 복용
- 건강기능식품 은행잎 ≠ 의약품 (함량·효과 자료 다름)

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 치매 예방 효과 없음(GEM, JAMA 2008) · 이명 비권장(Cochrane·AAO-HNS) · 파행 이득 없음(Cochrane)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

한눈에 보는 근거 — 어디에 무엇이 강한가

적응증이 분명할 때, 가장 근거가 강한 선택을 고릅니다

실로스타졸

★★★★★ 보행거리를 가장 많이 늘림.
운동요법과 함께 1차 (심부전엔 금기).

디오스민·미세정제 플라보노이드 분획(MPFF)

★★★★★ 증상·부종 개선 근거가 가장 두터움.
압박요법과 함께 사용.

호스체스트넛

★★★★ 단기 부종·증상 개선에 근거 있음
(대증 보조).

펜톡시필린

★☆☆☆☆ 간헐성 파행에는 효과 근거가 약해
권장하지 않음.

은행엽 치매 예방

✕ 대규모 연구에서 예방 효과 입증 실패.

은행엽 이명

✕ 근거 약하고 일관되지 않아 표준치료 아님.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 네트워크 메타분석(PLOS One 2022) · ESVS 2022 · ACC/AHA 2024 · Cochrane · GEM(JAMA 2008)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

출혈 · 휴약 · 금기 — 안전하게 드세요

시술 전 복용 알리기, 약물 병용, 금기를 꼭 확인합니다

함께 먹으면 출혈 위험 ↑

은행엽·실로스타졸·항혈소판제를 아스피린·항응고제와 함께 쓰면 출혈 위험이 커집니다 — 병용 전 꼭 상의하세요.

내시경·수술 전엔 미리 알리기

스스로 끊지 마세요. 출혈 위험이 낮은 검사는 대부분 그대로 먹고, 출혈 위험이 높은 시술만 의료진이 약별로 정합니다. 미리 알리면 의료진이 결정합니다.

심부전·임신은 특히 주의

실로스타졸은 심부전 환자에게 금기입니다. 은행엽 등 임신 중 피해야 하는 약도 많습니다.



그림 · 출혈 · 휴약 · 금기 — 안전하게 드세요(설명용 그림)

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ACC/AHA 2024 말초동맥질환 지침 · ESVS 2022 · 영국·유럽소화기내시경학회 2021 · 한국 IDEN 합의 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

집에서 기억할 7가지

원인에 맞는 약을, 안전하게 — 핵심만 모았습니다

01 다리가 무겁고 부으면 — 압박스타킹·다리 올리기·자주 걷기 먼저

02 걸으면 종아리가 아프면 — 참지 말고 진료, 금연이 가장 중요

03 저림·시림은 — '혈액순환'으로 단정 말고 원인 검사부터

04 은행잎은 — 치매 예방·이명 목적의 장기 복용은 효과 근거 없음

05 아스피린·항응고제 복용 중이면 — 병용 전 꼭 상의

06 내시경·수술·발치 전 — 복용 중인 약을 미리 알리기

07 실로스타졸은 — 심부전이 있으면 복용 금지

증상의 원인에 맞는 약을, 안전하게 — 함께 정합니다

근거 · 광교바른내과 일반내과 · 처방 전 담당 의사와 상의하세요

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 내시경 전 약 확인은 내시경 전 항혈전제 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

환자와 보호자를 위한 설명자료입니다. 진단과 처방은 담당 의료진과 상의하세요.

참고한 자료

ESVS 2022 정맥질환 지침 · ACC/AHA 2024 말초동맥질환 지침 · Cochrane 2020

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요